緩和ケアと地域連携

地域で支える緩和ケア

— 私たちにできること

参考文献

2026-03-26 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

あなたが関わっている利用者さんの中で…

「この方、最近つらそうだな」
「もう少し何かできることがあるんじゃないかな」
と感じたことはありませんか？ その「気づき」こそが、緩和ケアの出発点です。

今日のゴール

今日、持って帰ってほしいこと

1. 緩和ケアは「終末期だけのもの」ではないとわかる
2. あなたの職種でできる緩和ケアが1つ見つかる
3. 困ったときに誰に相談すればいいかがわかる

「自分には関係ない」から「自分にもできることがある」へ。この変化が今日のゴールです。

まず、誤解を解きましょう

「緩和ケア」と聞いて、何を思い浮かべますか？

誤解	実際
終末期の人だけが受けるもの	診断されたときから始められる
がんの人だけが対象	心不全、認知症、呼吸器疾患なども対象
特別な専門家だけがやること	すべての職種が関われる
「もう何もできない」ということ	「できることはまだたくさんある」ということ

WHOの定義をやさしく

緩和ケアとは

重い病気に向き合う患者さんとご家族の「つらさ」を和らげて、その人らしい生活を支えること

「つらさ」は、全人的苦痛（トータルペイン）として次の4つの面で捉えられます。

WHOの定義をやさしく（続き）

面	例
体のつらさ	痛み、息苦しさ、だるさ
心のつらさ	不安、悲しみ、怒り
人とのつながりのつらさ	孤独、家族との関係
生きる意味のつらさ	「何のために生きているのか」

体のつらさだけが緩和ケアではありません。

地域包括ケアの中の緩和ケア

地域包括ケアシステムと緩和ケア

領域	内容
医療	病院・診療所・訪問診療
介護	施設・在宅サービス（ここにいるのが皆さん）
予防	健康づくり
生活支援	住まい・見守り

緩和ケアは、このすべてに横串を通すもの。

利用者さんの「つらさ」は、医療の場だけでなく、介護の場、生活の場で日々感じられている。

数字で見るギャップ

知っていましたか？

日本緩和医療学会員への調査（2025年2～3月、回答528名）によると…

地域での緩和ケア教育の実施	割合
地域の医療従事者向け	約5割
地域の介護従事者向け	約1割

介護従事者向けの緩和ケア教育は、医療従事者向けに比べて少ないようです。

数字で見るギャップ（続き）

職種	施設での関わり（目安・施設により異なります）
介護職	日常のケアを通して、最も長く関わる
看護師	日中の観察や処置のたびに関わる
医師	診察・回診などの限られた時間

一番近くにいるあなたの「気づき」が、大切な手がかりになります。

あなたの職種でできること

緩和ケアは特別なことではありません

職種	あなたにできる緩和ケア
介護士	日常の変化に気づく。「いつもと違う」を伝える。声かけ、傾聴、安楽な姿勢の工夫
看護師	症状の評価、医師への報告、ケアプランへの反映、介護職の相談窓口
リハビリ職	「できること」を維持する支援、動作時の痛みの評価、リラクゼーション
事務職員	家族への丁寧な対応、環境整備、情報連携のサポート
栄養士	食べたいものを聞く、食べやすい形態の工夫、栄養より「楽しみ」
相談員	家族の不安への寄り添い、社会資源の紹介、意思決定の支援

「自分の仕事の延長線上」に緩和ケアはあります。

ケース

具体的な場面で考えてみましょう

場面1: 朝の声かけ

- いつもの「おはようございます、よく眠れましたか？」
- これだけで立派な緩和ケアのアセスメントです。
- ひと言の例：
  - 「体のどこか痛いところはありませんか？」
  - 「何か気になっていることはありますか？」
  - 「昨日のお薬は楽になりましたか？」

場面2: 食事の場面

- 食事量が減ってきた利用者さんに
- 避けたい声かけ：「ちゃんと食べないと元気になれませんよ」
- 添えたい声かけ：「食べたいものはありますか？少しでも好きなものを」

場面3: 入浴の場面

- 入浴を嫌がるようになった利用者さん
  - 痛みで動くのがつらい？
  - 裸になることへの抵抗？
  - 体力が落ちて疲れる？
- 「嫌がる」の背景を考えること。それが緩和ケア的思考

グループワーク（5分間）

3-4人グループで話してみましょう

「あなたが関わった利用者さん（患者さん）で、もっとこうできたらよかったな、と思ったことは？」

ルール：

- 正解はありません
- 批判しない、聞くことに集中
- 「自分だったらどうする？」を考えてみる
- 個人情報に配慮（名前は出さない）

1人1分ずつ話して、残り1分で「共通点」を見つけてください。

グループワークの共有

いくつかのグループに聞いてみましょう

ファシリテーターが2-3グループに発表を依頼します。

ポイント:

- 「気づいていた」のに「何もできなかった」経験が多い
  - それは「知識がなかった」のではなく「伝え方を知らなかった」だけ
- 今日からその「伝え方」を一つずつ学んでいきましょう

困ったときの相談先

一人で抱えないでください

あなたが「何かおかしい」と感じたら：

1. まず看護師に伝える
   - 「○○さん、いつもと違って△△な様子です」
2. 看護師が判断して医師に報告
   - 必要に応じて緩和ケアチームに相談
3. カンファレンスで情報共有
   - あなたの「気づき」がチーム全体のケアを変える

大切なのは「正確な医学的判断」ではなく、「いつもと違う」と感じたことを伝えること。

連絡先

誰に伝えるか

連絡先	役割
フロアの看護師	日常の気づきの第一報告先
施設看護師長	看護師不在時の相談先
施設医師	症状の評価と治療方針
地域の緩和ケアチーム	専門的な相談（施設から依頼）

施設ごとの連絡先は別紙参照

多職種で支えるということ

一人で抱えない。チームで支える



全員の「気づき」が集まって、はじめて「その人らしいケア」が実現する。

介護職の「気づき」は、医師や看護師には見えないものを含んでいます。
あなたの目は、かけがえのないものです。

まとめ

今日のまとめ

3つだけ覚えてください

1. 緩和ケアは「終末期だけ」「がんだけ」のものではない
   - つらさを和らげること、すべてが緩和ケア
2. あなたの「いつもと違う」という気づきが出発点
   - 専門知識がなくても大丈夫。感じたことを伝えよう
3. 一人で抱えない。看護師に伝えることから始めよう
   - あなたの一言がチームのケアを変える

小さな一歩から

明日からできる「たった一つのこと」

> *明日から、利用者さんに一つだけ、いつもの声かけに「＋ひと言」を加えてみてください。*

例：

- 「痛いところはありませんか？」
- 「何か気になることはありますか？」
- 「最近、眠れていますか？」

ワークシート（配布）に書いてください：

- 「明日から試してみたい＋ひと言」を1つ
- 1週間後に「やってみてどうだったか」を共有する時間を設けます

おわりに

緩和ケアは、特別なことではありません。

目の前の人の「つらさ」に気づき、寄り添い、伝える。

それは、皆さんが毎日していることの延長線上にあります。

ありがとうございました。質問・感想があればいつでもお声がけください。

出典

本スライドの出典: 川島有沙ほか「地域包括ケアにおける緩和ケアの普及に向けた取り組みの調査報告」Palliative Care Research 21(1):69-73, 2026(DOI 10.2512/jspm.21.69)／WHO緩和ケアの定義(2002)。4つのつらさ(トータルペイン)は Saunders らのホスピスケアの考え方による

作成: Learning Design Lab / AI Agent Team

参考文献